Hjelp! Petter må bestå helsefag eksamen!!

Han trenger ekstra cash til en skikkelig klokke!!

HEA3103 Vår 2025

Oppgave 1 ca. 60 %, oppgave 2 ca. 40 %

Case / situasjon

Sted: Demensavdeling, Solsiden sykehjem, Tromsø

Pasient: Anne Larsen, f. 10.02.1946, gift. Pårørende: ektefelle og datter i nærheten.

Diagnoser: Demens. Nedsatt hørsel (høreapparat).

Utfordringer: Blir lett forvirret og sint ved ting hun ikke forstår. Kan utagere fysisk/verbalt og opptre truende. Urolig, vandrer mye.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: klarer selv med veiledning.
- Fysisk: liker tur og sansehage.
- Psykisk: trenger ro og trygge omgivelser.
- Sosialt: liker aktiviteter på avdelingen.
- Åndelig: glad i naturen.
- Kommunikasjon: sint ved mange spørsmål/krav; vansker med å forstå og finne ord.
- Ernæring: liker å smøre maten selv, deltar i felles måltider, drikker lite.

Oppgaver og eksempelsvar

Oppgave 1

Oppgavetekst: Du skal veilede Anne i personlig hygiene og tilrettelegge for frokost. Lag en tiltaksplan der du beskriver hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du velger å gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

Anne Larsen bor på demensavdelingen ved Solsiden sykehjem. Hun har demens og nedsatt hørsel, og hun blir lett forvirret og sint når hun ikke forstår. Hun kan utagere og vandrer mye. Hun klarer hygiene selv med veiledning, liker å smøre maten selv og deltar i felles måltider, men drikker lite. Jeg skal veilede henne i personlig hygiene og tilrettelegge for frokost. Målet er at Anne gjør mest mulig selv, at morgenen blir rolig og trygg, og at hun får i seg mat og drikke.

Hoveddel

Jeg forbereder meg før jeg går inn til Anne. Jeg leser rapporten fra natten for å vite om hun har sovet og hvordan hun har det. Jeg legger fram håndkle, toalettsaker og klær, slik at stellet kan skje uten at jeg må lete. Når jeg går inn, banker jeg på, sier navnet mitt og møter henne rolig og vennlig. Jeg sjekker at høreapparatet sitter og virker.

Journalen sier at Anne blir sint av mange spørsmål og krav, og at hun har vansker med å forstå og finne ord. Derfor bruker jeg korte setninger, én beskjed om gangen, og jeg viser mer enn jeg forklarer. Jeg kan for eksempel gi henne vaskekluten og vise at hun kan vaske ansiktet. Jeg lar henne gjøre det hun klarer, og jeg hjelper bare der det trengs. Jeg gir henne enkle valg, som mellom to gensere. Slik får hun medvirke uten å bli overveldet. Hvis hun blir sint eller sier nei, diskuterer jeg ikke. Jeg trekker meg litt tilbake, avleder med noe hun liker, og prøver igjen senere. Det er bedre å utsette stellet enn å skape en situasjon der hun blir redd og utagerer.

Underveis observerer jeg hud, humør og om hun virker å ha vondt. Fordi hun drikker lite, ser jeg også etter tegn på urinveisinfeksjon, som økt forvirring eller uro, og melder det til sykepleier.

Til frokost følger jeg henne til fellesbordet, fordi hun liker å delta i felles måltider. Jeg velger en rolig plass med lite støy, slik at hun hører og ikke blir stresset. Jeg setter fram brød og pålegg og lar henne smøre maten selv. Det gir mestring og selvfølelse. Jeg setter et glass med noe hun liker å drikke foran henne og minner henne vennlig på å drikke. Jeg kan gjerne drikke sammen med henne, fordi personer med demens ofte gjør det andre gjør. Nok væske forebygger forvirring, forstoppelse og urinveisinfeksjon.

Etterpå dokumenterer jeg hvordan stellet gikk, hva som fungerte, hva hun spiste og hvor mye hun drakk. Jeg gir rapport til sykepleier. Helsepersonelloven krever dokumentasjon, og den hjelper kollegene til å møte Anne på samme måte, noe som gir henne trygghet.

Jeg evaluerer morgenen ved å se om stellet og frokosten gikk uten at hun ble sint, om hun gjorde mye selv, og om hun drakk nok. Hvis det ofte blir konflikter, tar jeg det opp med sykepleier, og vi kan spørre ektefellen eller datteren om hvilke vaner hun hadde før.

Avslutning

Tiltaksplanen er bygget rundt Annes behov for ro og trygghet. Jeg bruker enkel kommunikasjon, lar henne gjøre mest mulig selv og unngår press. Ved frokosten bygger jeg på at hun liker å smøre maten selv og spise sammen med andre, og jeg følger opp at hun drikker lite. Slik får hun hjelp på en måte som bevarer verdigheten.

Oppgave 2

Oppgavetekst: Anne er urolig og vandrer mye. Foreslå aktiviteter ut fra Annes funksjonsnivå og begrunn faglig hvorfor du har valgt disse aktivitetene. Målet er å redusere uro, vandring og forvirring.

Eksempelsvar

Innledning

Anne er urolig og vandrer mye. Hun har demens og nedsatt hørsel, og hun blir forvirret og sint av mange krav og spørsmål. Journalen sier at hun liker tur, sansehage og aktiviteter på avdelingen, og at hun er glad i naturen. Målet er å redusere uro, vandring og forvirring. Jeg vil ikke stoppe vandringen for enhver pris, men finne aktiviteter som møter behovene bak uroen.

Hoveddel

Vandring hos personer med demens kan ha mange årsaker, for eksempel behov for bevegelse, kjedsomhet, smerter, toalettbehov, sult, tørste eller at personen leter etter noe kjent. Derfor starter jeg med å observere når Anne blir urolig. Er det til faste tider på dagen, etter måltider eller når det er mye støy? Fordi hun drikker lite, sjekker jeg også at hun får nok drikke. Hvis uroen er ny eller verre enn vanlig, melder jeg det til sykepleier, fordi det kan skyldes smerter eller infeksjon.

Den første aktiviteten jeg foreslår, er tur i sansehagen eller en kort tur ute. Anne liker tur og natur, og hun er glad i naturen også på et åndelig plan. Når hun får gå sammen med noen i rolige omgivelser, får hun dekket behovet for bevegelse på en trygg måte. Frisk luft og dagslys kan også gi bedre søvn og mindre uro om kvelden. Jeg går ved siden av henne i hennes tempo, peker på blomster eller fugler og sier lite. Naturen kan gi ro uten at hun må svare på spørsmål.

Den andre aktiviteten er enkle hverdagsoppgaver, som å brette håndklær, vanne blomster eller dekke bordet. Slike oppgaver kjenner hun ofte fra før, og de gir en følelse av å være til nytte. Jeg viser hva vi skal gjøre i stedet for å forklare mye, og jeg gjør oppgaven sammen med henne. Det gir mestring og mening, noe som kan dempe uro som kommer av kjedsomhet.

Den tredje aktiviteten er en rolig stund med musikk eller å se på bilder av natur, gjerne én-til-én i et stille rom. Jeg sjekker at høreapparatet virker. Musikk kan gi gode følelser og ro, også når språket er svekket. Hvis datteren eller ektefellen vet hvilken musikk hun liker, bruker jeg det.

I alle aktivitetene møter jeg Anne med ro. Jeg bruker korte setninger, bekrefter følelsene hennes og retter ikke på henne hvis hun sier noe som ikke stemmer. Dette kalles validering, og det gir trygghet. Jeg avbryter hvis hun blir sliten eller overstimulert. Jeg prøver å tilby aktiviteten før uroen blir sterk, fordi det er lettere å forebygge enn å roe henne ned.

Jeg dokumenterer hvilke aktiviteter som fungerte og når på dagen, og gir rapport. Over tid kan vi se om Anne vandrer mindre, virker roligere og sjeldnere blir sint.

Avslutning

Aktivitetene bygger på det Anne liker og klarer: tur og natur, hverdagsoppgaver og rolig musikk. Ved å se på hvorfor hun vandrer og tilby meningsfull aktivitet i stedet for å stoppe henne, kan uro og forvirring bli mindre. Slik blir hverdagen tryggere for Anne.

Eksempelsvar til øving, skrevet med sikte på et nivå mellom karakter 4 og 5. Uoffisielt – ikke en karaktergaranti eller offisielt fasitsvar.